

1. Un anévrisme est une dilatation localisée et temporaire d'un vaisseau artériel.	1. Faux
2. Un anévrisme est caractérisé par une augmentation du diamètre artériel supérieure à 50% et une perte de parallélisme des parois.	2. Vrai
3. L'anévrisme vrai implique uniquement une dilatation de l'intima et de la média.	3. Faux
4. Les anévrismes de l'aorte sont plus fréquents que ceux des artères iliaques.	4. Vrai
5. Les maladies du tissu élastique sont l'étiologie principale des anévrismes artériels.	5. Faux
6. Le diamètre normal de l'aorte abdominale est de 30 mm chez l'homme.	6. Faux
7. Le tabagisme n'est pas associé à un risque accru d'anévrisme de l'aorte.	7. Faux
8. Les antécédents familiaux d'anévrisme augmentent le risque de développer un anévrisme de l'aorte.	8. Vrai
9. La prédominance des anévrismes de l'aorte chez l'homme est principalement due à l'athérome.	9. Vrai
10. Les anévrismes résultent de la perte de la résistance de la paroi artérielle à l'étirement.	10. Vrai
11. Les anévrismes de l'aorte tendent à augmenter de diamètre selon la loi de Laplace.	11. Vrai
12. Les anévrismes de l'aorte ne présentent aucun risque de rupture.	12. Faux

13. Le risque de rupture d'un anévrisme augmente quand le diamètre de l'artère augmente.	13. Vrai
14. La rupture d'un anévrisme est généralement asymptomatique.	14. Faux
15. Les anévrismes symptomatiques peuvent provoquer des douleurs abdominales aiguës.	15. Vrai
16. Les épreuves fonctionnelles respiratoires ne sont pas nécessaires pour évaluer l'opérabilité d'un anévrysme aortique abdominal.	16. Faux
17. La surveillance par échographie est recommandée pour tous les anévrismes de l'aorte peu importe leur taille.	17. Vrai
18. Les anévrismes inflammatoires sont traités par des corticostéroïdes à dose élevée puis dégressive.	18. Vrai
19. Les anévrismes inflammatoires ne nécessitent jamais de traitement chirurgical.	19. Faux
20. Les anévrismes infectieux présentent un risque élevé de rupture.	20. Vrai
21. Les anévrismes infectieux ne sont jamais associés à des douleurs abdominales ou lombaires.	21. Faux
22. Le dépistage des anévrismes est recommandé uniquement pour les hommes de plus de 65 ans.	22. Faux
23. Les anévrismes de l'aorte sont souvent découverts de manière fortuite lors d'un examen échographique.	23. Vrai
24. Le traitement endoluminal est toujours préférable à la chirurgie classique pour les anévrismes de l'aorte.	24. Faux
25. L'endofuite est une complication courante après un traitement endoluminal des anévrismes.	25. Vrai
26. La tomodensitométrie est plus efficace que l'échographie pour évaluer le diamètre maximal d'un anévrisme.	26. Vrai

27. Les patients atteints d'AAA présentant des douleurs abdominales aiguës doivent être opérés en urgence.	27. Vrai
28. Les fonctions cardiaque et rénale doivent être évaluées chez les cas d'AAA candidats à la cure chirurgicale.	28. Vrai
29. La fibrose périanévrismale est une caractéristique des anévrismes inflammatoires.	29. Vrai
30. Les anévrismes infectieux sont généralement causés par une contamination par voie digestive.	30. Faux
31. Les AAA peuvent entraîner des coliques néphrétiques par compression de l'urètre.	31. Faux
32. Les patients présentant un anévrisme de l'aorte ne nécessitent aucun suivi après la chirurgie.	32. Faux
33. Les hommes de 60 ans sans antécédents familiaux d'anévrisme de l'aorte ne nécessitent pas de dépistage.	33. Vrai
34. Les facteurs de risque cardiovasculaire n'ont aucun impact sur le développement d'un anévrisme.	34. Faux
35. Les anévrismes de l'aorte ne peuvent pas être détectés par la palpation abdominale.	35. Faux
36. Le traitement médical est la première option pour tous les types d'anévrismes.	36. Faux
37. La fibrose périanévrismale peut englober des structures adjacentes comme l'uretère, le sigmoïde et la VCS.	37. Faux
38. La fièvre est un symptôme courant des anévrismes inflammatoires.	38. Vrai
39. Les anévrismes inflammatoires de l'aorte peuvent entraîner un amaigrissement et une anorexie.	39. Vrai
40. Le traitement chirurgical est le seul traitement nécessaire pour les anévrismes infectieux.	40. Faux
41. Le dépistage est recommandé pour patients âgés de 40 à 75 ans avec des antécédents familiaux d'anévrisme.	41. Faux

42. Les patients présentant un petit anévrisme de l'aorte ne nécessitent pas de surveillance régulière.	42. Faux
43. Les patients atteints d'AAA doivent être informés des conséquences du dépistage avant de le subir.	43. Vrai
44. Les complications postopératoires des anévrismes de l'aorte sont principalement d'ordre respiratoire.	44. Faux
45. Les endoprothèses sont préférable à la chirurgie chez les patients présentant des tortuosités aortiques.	45. Faux
46. Les anévrismes de l'aorte sont plus fréquents chez les femmes que chez les hommes.	46. Faux
47. L'athérome est une étiologie rare des anévrismes de l'aorte.	47. Faux
48. Les anévrismes inflammatoires peuvent être traités uniquement par des médicaments.	48. Vrai
49. Le dépistage des anévrysmes aortiques n'est pas indiqué chez les hommes de plus de 75 ans.	49. Vrai
50. Les patients atteints d'anévrisme de l'aorte ne présentent aucun risque de décès prématuré.	50. Faux
51. La palpation abdominale est un moyen efficace de diagnostiquer un anévrisme aortique.	51. Vrai
52. Le traitement endoluminal des AAA est associés à une plus faible mortalité que la chirurgie classique.	52. Vrai
53. Les antécédents familiaux d'anévrisme ne sont pas un critère de dépistage pour les femmes de 50 ans.	53. Faux
54. La prévalence des anévrismes de l'aorte est en baisse parallèlement à une augmentation du tabagisme.	54. Faux
55. Le traitement médical est une option viable pour tous les types d'anévrismes.	55. Faux
56. La localisation la plus fréquente des anévrismes aortiques est l'aorte abdominale sous-rénale.	56. Vrai

57. Les anévrismes thoraco-abdominaux impliquent uniquement l'aorte ascendante.	57. Faux
58. Les anévrismes de l'aorte thoracique sont rarement asymptomatiques.	58. Faux
59. La rupture d'un anévrysme de l'aorte thoracique peut se manifester par une hématomé.	59. Vrai
60. La tomodensitométrie thoracique est un examen utile pour évaluer les anévrismes de l'aorte thoracique.	60. Vrai
61. Les anévrismes de l'aorte thoracique ne nécessitent jamais de traitement chirurgical.	61. Faux
62. La mortalité postopératoire est plus élevée avec les endoprothèses qu'avec les prothèses en Dacron après le traitement chirurgical d'un anévrysme thoraco-abdominal.	62. Faux
63. La paraplégie est une complication des traitements des anévrysme de l'aorte abdominale.	63. Faux
64. Les anévrismes iliaques sont souvent asymptomatiques et causés par une athérosclérose.	64. Vrai
65. Les anévrismes poplités sont plus fréquents chez les femmes que chez les hommes.	65. Faux
66. Les anévrismes poplités sont rarement bilatéraux.	66. Faux
67. Les anévrismes poplités sont souvent associés à l'anévrysme de l'aorte abdominale.	67. Vrai
68. La rupture est la présentation clinique la plus fréquente des anévrismes poplités.	68. Faux
69. Les faux anévrismes fémoraux sont souvent iatrogènes post-ponction artérielle.	69. Vrai
70. Le traitement des faux anévrismes fémoraux implique toujours une intervention chirurgicale.	70. Faux

71. Les anévrismes des artères viscérales sont fréquents.	71. Faux
72. Les anévrysmes des artères viscérales atteignent le plus souvent l'artère splénique.	72. Vrai
73. Les anévrismes de l'artère splénique présentent un risque élevé de rupture lors de la grossesse.	73. Vrai
74. Les anévrismes de l'artère splénique sont toujours traités par embolisation percutanée.	74. Vrai
75. Les anévrismes de l'artère hépatique nécessitent rarement un traitement chirurgical.	75. Faux
76. Les anévrismes iliaques sont le plus souvent situés sur les iliaques externes.	76. Faux
77. Les anévrismes iliaques présentent un risque de rupture dans la veine iliaque.	77. Vrai
78. Les anévrismes poplités sont souvent traités par la mise en place d'une prothèse en Dacron.	78. Faux
79. Une augmentation du diamètre artériel de 40% n'est pas considéré comme un anévrysme.	79. Vrai
80. L'anévrysme vrai comprend toutes les tuniques de la paroi.	80. Vrai
81. Le faux anévrysme correspond à un hématome sous-intimal encapsulé contenu par la média.	81. Faux
82. Les anévrysmes des artères rénales ou carotides sont plus rares.	82. Vrai
83. Le diamètre de l'aorte abdominale normal est d'environ 20mm.	83. Vrai
84. L'anévrysme est défini par un diamètre antéropostérieur de l'aorte abdominale de >35mm chez la femme.	84. Faux
85. Le tabagisme est un facteur de risque majeur d'anévrysme de l'aorte abdominale.	85. Vrai

86. La prévalence de l'AAA est d'environ 4% chez les hommes ayant arrêté de fumer.	86. Faux
87. La prévalence de l'AAA est de moins d'1% chez les hommes n'ayant jamais fumé.	87. Vrai
88. L'arrêt du tabac ne réduit par le risque d'anévrisme de l'aorte abdominale.	88. Faux
89. La prévalence de l'AAA est de 0,4% chez les femmes et de 1,7% chez les hommes.	89. Vrai
90. La prévalence de l'AAA est plus élevée en cas d'AOMI, d'antécédents d'AIT/AVC ou d'insuffisance coronaire.	90. Vrai
91. Les phénomènes inflammatoires entraînent une perte des fibres élastiques et un épaissement de la paroi en cas d'athéromatose.	91. Faux
92. Les facteurs génétiques n'interviennent pas dans le risque d'anévrisme de l'aorte abdominale.	92. Faux
93. Les anévrismes dans le cadre de maladies du tissu élastique (Marfan, Ehlers-Danlos,...) sont rares.	93. Vrai
94. La maladie de Behçet peut entraîner un anévrisme inflammatoire de l'aorte abdominale.	94. Vrai
95. Le diamètre augmente en moyenne de 8mm/an en cas d'anévrisme de l'aorte abdominale.	95. Faux
96. La dilatation artérielle est de plus en plus lente quand le diamètre de l'artère augmente.	96. Faux
97. Le risque de rupture d'anévrisme augmente nettement quand le diamètre artériel atteint 60mm.	97. Vrai
98. Une augmentation rapide du diamètre >5mm/6 mois est un facteur de risque de rupture d'anévrisme.	98. Vrai
99. Un anévrisme aortique abdominal de 50mm de diamètre est à très haut risque de rupture.	99. Faux

100.	L'anévrisme est défini par un diamètre antéropostérieur de l'aorte abdominale de >35mm chez l'homme.	100. Vrai
101.	Le signe de De Bakey est caractéristique d'un anévrisme aortique sus-rénal.	101. Faux
102.	Une augmentation rapide du diamètre <1cm/an est un facteur de risque de rupture d'anévrisme.	102. Faux
103.	La palpation de l'abdomen montre une masse pulsatile refoulant les mains à chaque systole en cas d'AAA.	103. Vrai
104.	Un anévrisme de l'aorte abdominale douloureux est une indication de chirurgie peu urgente.	104. Faux
105.	La tomodensitométrie permet de diagnostiquer un AAA en cas de symptômes non spécifiques.	105. Vrai
106.	Le signe de De Bakey est positif si on peut introduire la main entre l'anévrisme de l'AA et le rebord costal.	106. Vrai
107.	Des douleurs thoraciques ou lombaires aiguës doivent faire suspecter la fissuration d'un AAA.	107. Faux
108.	La rupture intrapéritonéale d'un anévrisme est généralement mieux tolérée que la rupture rétropéritonéale.	108. Faux
109.	Un anévrisme de l'aorte abdominale peut se rompre dans un organe creux comme le colon ou la VCI.	109. Vrai
110.	La rupture rétropéritonéale d'un AAA provoque un collapsus sévère et brutal.	110. Faux
111.	Une compression de la veine cave supérieure par un AAA provoque un œdème du membre supérieur.	111. Faux
112.	Les AAA peuvent se manifester par la migration d'embolies provoquant des ischémies de membre.	112. Vrai
113.	Les « orteils bleus » ne sont jamais associés aux anévrysmes de l'aorte abdominale.	113. Faux
114.	La radiographie de l'abdomen à blanc est l'examen de 1 ^{er} choix pour diagnostiquer les AAA.	114. Faux

115.	La radiographie de l'abdomen à blanc permet de visualiser des calcifications de la paroi vasculaire.	115. Vrai
116.	L'échographie abdominale est l'examen de 1 ^{er} choix pour le dépistage et la surveillance des AAA.	116. Vrai
117.	Le scanner sans produit de contraste n'est pas utile pour diagnostiquer les anévrysmes aortiques.	117. Faux
118.	La tomodensitométrie avec contraste est indiquée uniquement pour guider la stratégie thérapeutique en cas d'anévrysme de l'aorte abdominale.	118. Vrai
119.	Les antiagrégants plaquettaires comme l'héparine sont utilisés pour traiter l'AAA asymptomatique.	119. Faux
120.	Le traitement chirurgical des AAA est associé à une mortalité post-opératoire d'environ 4%.	120. Vrai
121.	Le traitement chirurgical des AAA consiste à retirer le sac anévrysmal et à suturer la paroi artérielle.	121. Faux
122.	Les complications tardives de la cure chirurgicale classique de l'AAA sont fréquentes.	122. Faux
123.	Le traitement chirurgical des AAA consiste à mettre une prothèse en Dacron à l'intérieur de l'anévrysme.	123. Vrai
124.	La nécrose colique fait partie des complications les plus fréquentes du traitement endoluminal des anévrysmes de l'aorte abdominal.	124. Faux
125.	L'IC, la pneumonie, l'infarctus myocardique, l'IR et l'insuffisance respiratoire font partie des complications post-opératoires les plus fréquentes du traitement chirurgical des anévrysmes de l'aorte abdominal.	125. Vrai
126.	Le traitement endoluminal de l'AAA provoque la thrombose complète du sac anévrysmal.	126. Vrai

127.	Le traitement endoluminal de l'AAA est associée à une mortalité plus importante que la chirurgie.	127. Faux
128.	Le traitement endoluminal de l'AAA provoque moins de complications cardiaques ou pulmonaires.	128. Vrai
129.	Le traitement endoluminal de l'AAA exclut l'anévrisme de la circulation.	129. Vrai
130.	Les anévrismes de l'aorte abdominale <55mm sont traités par chirurgie.	130. Faux
131.	Les endofuites sont détectés par échographie abdominale après le traitement endoluminal des AAA.	131. Faux
132.	Le traitement endoluminal des AAA est plus bénéfique que la chirurgie sur la mortalité à long terme.	132. Faux
133.	Un AAA de >55cm ou qui augmente de >5mm en 6 mois est une indication opératoire.	133. Faux
134.	L'espérance de vie et les comorbidités sont prises en compte dans les indications de traitement d'AAA.	134. Vrai
135.	Une coronaropathie doit être recherchée en cas de signes d'appel dans le bilan d'opérabilité d'un AAA.	135. Vrai
136.	Une altération de la fonction hépatique est associée à un risque hémorragique lors d'une opération.	136. Vrai
137.	La fonction rénale est un facteur pronostique dans le traitement des AAA.	137. Vrai
138.	Le bilan d'opérabilité des AAA inclut un CT-scanner des vaisseaux du cou.	138. Faux
139.	Les AAA de <55mm nécessitent uniquement une surveillance échographique tous les 6 mois.	139. Vrai
140.	Les AAA asymptomatiques de >55mm ne doivent pas être opérés.	140. Faux
141.	Le traitement de l'anévrisme rompu se fait le plus souvent par l'interposition d'une prothèse en Dacron.	141. Vrai

142. La mortalité péri-opératoire est de 70% dans le traitement de l'anévrisme aortique rompu.	142. Faux
143. Le dépistage et le traitement précoce permet une réduction de la mortalité liée aux AAA de 45%.	143. Vrai
144. Les anciennes fumeuses doivent être dépistées pour l'AAA entre 65 et 75 ans.	144. Vrai
145. Les AAA de 30 à 40mm doivent être surveillés par échographie tous les 6 à 12 mois.	145. Faux
146. Les anévrismes inflammatoires représentent 5 à 10% de tous les anévrismes de l'aorte.	146. Vrai
147. Les AAA de 40 à 54mm doivent être surveillés par échographie tous les mois.	147. Faux
148. Les anévrismes aortiques atteignent le plus souvent l'aorte descendante intra-thoracique.	148. Faux
149. La chirurgie est indiquée pour les anévrismes inflammatoires <55mm en cas d'échec du traitement médical par méthylprednisolone.	149. Vrai
150. Les AAA de 30 à 40mm doivent être surveillés par échographie tous les 1 à 3 ans.	150. Vrai
151. Les anévrismes infectieux sont toujours secondaires à une contamination par voie hématogène.	151. Faux
152. La tomodensitométrie montre une couronne inflammatoire hyperdense dans la paroi aortique calcifiée en cas d'anévrisme inflammatoire.	152. Faux
153. Les anévrismes isolés de l'aorte thoracique peuvent entrainer des douleurs interscapulaires.	153. Vrai
	154. Faux

154. Les anévrysmes isolés de l'aorte thoracique peuvent entrainer des symptômes respiratoires par compression des voies aériennes : toux, dyspnée, bronchopneumonie, bronchiectasies,...	155. Vrai
155. La rupture d'un anévrysme de l'aorte thoracique peut provoquer des hémoptysies et un hémothorax.	156. Faux
156. La dysphagie est un symptôme des anévrysmes de l'aorte abdominale.	157. Vrai
157. L'imagerie par résonance magnétique et la radio de thorax sont utilisés pour diagnostiquer les anévrysmes de l'aorte thoracique.	158. Vrai
158. Les anévrysmes symptomatiques de l'aorte thoracique peuvent être opérés peu importe leur taille.	159. Faux
159. Les anévrysmes de l'aorte thoracique ne sont jamais opérés en cas de maladie du tissu élastique.	160. Vrai
160. Les anévrysmes de l'aorte ascendante de diamètre >55mm doivent être opérés.	161. Vrai
161. Un anévrysme de l'aorte descendante de 55mm n'est pas une indication de traitement chirurgical.	162. Faux
162. La mortalité post-opératoire d'un anévrysme thoraco-abdominal est d'environ 2% si une prothèse en Dacron a été posée.	
163. Les anévrysmes asymptomatiques de l'aorte descendante >60mm doivent être opérés.	163. Vrai
164. L'opération d'un anévrysme thoraco-abdominal nécessite la réimplantation des troncs viscéraux.	164. Vrai
165. La paraplégie est une complication des traitements des anévrysme de l'aorte thoracique.	165. Vrai

166.	La rupture d'un anévrisme iliaque provoque un hématome péritonéal aigu.	166. Faux
167.	Les anévrysmes iliaques asymptomatiques de >4cm doivent être opérés.	167. Vrai
168.	Les anévrysmes poplités représentent 70% des anévrysmes périphériques.	168. Vrai
169.	Les anévrysmes iliaques <55mm doivent uniquement être surveillés par échographie.	169. Faux
170.	La majorité des cas d'anévrysmes poplités sont unilatéraux.	170. Faux
171.	La thrombose est la manifestation clinique la plus fréquente des anévrysmes poplités.	171. Vrai
172.	Les anévrysmes poplités entraînent des embolisations périphériques et une ischémie chronique du MI.	172. Faux
173.	Les anévrysmes poplités asymptomatiques de >2cm de diamètre doivent être opérés.	173. Vrai
174.	Les anévrysmes iliaques sont le plus souvent traités par exclusion par greffe veineuse.	174. Faux
175.	Le pontage est le traitement de choix des anévrysmes fémoraux symptomatiques ou évoluant rapidement.	175. Vrai
176.	Les faux anévrysmes poplités sont traités par compression et injection de thrombine sous contrôle écho.	176. Faux
177.	Les anévrysmes des artères viscérales ne touchent jamais le tronc coeliaque.	177. Faux
178.	Les anévrysmes des artères viscérales peuvent provoquer une HTA et une hématurie.	178. Vrai
179.	La rupture des anévrysmes des artères viscérales peut entraîner une hémobilie ou un hemothorax.	179. Faux
180.	Les anévrysmes asymptomatiques de l'artère splénique doivent être traités chez la femme jeune.	180. Vrai